中華民國醫師公會全國聯合會
西醫基層醫療服務審查執行會南區分會
「110 年 12 月 8 日審查專家諮詢會議」會議紀錄

開會時間：110 年 12 月 8 日（三）下午 13:30

開會地點：台南市醫師公會三樓會議室(台南市東區裕德一街 2 號)-同步 Cisco Webex 視訊。

出席人員：

現場:
賴俊良主任委員、顏大翔副主任委員、丁榮哲副主任委員、陳相國委員、蔡國麟秘書長、劉維穆組長、李明陽副組長、楊忠錫總召、魏大倫副總召、陳俊文副總召、吳國榮委員、林士敦委員、周蓁佑委員、方崇名組員、陳雨利組員、劉伊薰組員。

視訊:
徐超群副主任委員、趙善楷副主任委員、端木梁組長、戴昌隆組長、葉雲宇副總召、李昭榮副總召、劉晉瑋副總召、陳炳誠副總召、王家麟副總召、李朝泰委員、曾立榮委員、李永輝委員、塗勝雄委員、夏保介委員、陳英杰委員、陳明煌委員、吳東泰組員、鄭熙騰組員、林俊良組員、陳璟毓組員、葉政南組員、吳孟輯組員、陳佩軍組員、林建宏組員、劉泰成組員、魏培釗組員、沈尊嚴組員、周志哲組員、李龍駒組員、何光哲組員、王國哲組員、心內科科召、小兒科科召、婦產科科召、眼科科召、皮膚科科召、精神科科召。

請假人員::
謝樂偉委員、周見成委員、杜佳軒組員、蔡瑞頒組員、林嘉祈組員、廖寶全組員、張逸民組員、呂俊忠組員、顏純民顧問、朱嘉生顧問、王正坤顧問、黃仁享顧問、張金石顧問、神經內科科召、泌尿科科召。

主席：賴俊良主任委員

會務人員：陳美惠、周芷妤　　紀錄與整理:陳美惠

壹、 報告(決行)事項：

🖊南委會 2021/12/08 因應疫情採取實體與線上會議,俊良主委首先感謝台南市醫師公會提供南委會開會視訊軟體、場地與點心，並表示若會員醫師有受到不當合理對待，請與各醫師公會和南委會聯絡，當盡最大努力幫助會員醫師解決問題。另外健保署開發 BI 結合 AI 系統，顯示在疫情趨緩之際，地區醫院業務成長率攀升，然而基層院所恢復緩慢，期待借鏡地區醫院經驗來幫助基層院所。

🖊相國理事長於會中特別感謝俊良主委和各委員們對案件審查和管理盡心盡力的付出，並分享總額協商過程以及感謝各縣市理事長共同努力爭取，讓全國醫師受惠。

🖊會中相國理事長、雲林縣榮哲理事長、嘉義市善楷理事長和嘉義縣超群理事長案例分享，呼籲會員醫師若有健保誤報或審查相關問題可尋求各醫師公會和南委會協助。

🖊會議重要討論議案羅列如下：

📍追認重申及討論南區糖尿病用藥審查共識：

1. TZD、DPP4i 和 SGLT2i，符合此三類藥物給付規定並檢附起始治療相關病歷與檢驗報告，經具體詳實記載新的臨床症狀，有轉換必要時，三者得相互轉換，例如，因水腫將 TZD 轉成 DPP4i，或有 CHF、CKD、Albuminuria 將 DPP4i(或 TZD)轉成 SGLT2i 等。

2. 可開立 TZD、DPP4i 和 SGLT2i 之狀態如下：

①已接受 Metformin 劑量達 1000mg/day 三個月以上，且 HbA1C 仍≧7%之 type2DM 患者。

② Metformin 有禁忌症（如 eGFR<30)或副作用，可第一線開立。

③ 80 歲以上 type2DM 病人，未使用過 Metformin 者。但若之前已使用 Metformin 且病情穩定，Cr 正常，則仍可續用 Metformin。

3. DPP4i/SGLT2i 複方製劑的開立：已接受最大耐受劑量 Metformin，且併用 SGLT2i 或 DPP4i 治療至少 6 個月，無需連續 2 次 HbA1C 大於 7.5%，於第 6 個月 HbA1C 大於 7.5%者即可開立。

📍有關 HCV reflex testing 申報方式及 HCV RNA 定量檢驗管控：HCV RNA 檢驗需於 Anti-HCV 陽性後方能檢測，且需事先於 VPN 查詢有無重複檢驗，並將檢驗結果上傳雲端。此外建議健保署做重複檢驗 API 提醒和請南區業務組做相關檔案分析，討論管控方式，避免重複及不必要之檢驗。

📍追認增列 DM 用藥 GLP-1-insulin 複方針劑 checklist：限已接受最大耐受劑量 Metformin 及/或 Sulfonylurea 類藥物，且併用下列藥品之一持續 6 個月後，HbA1C 仍高於 8.0% 之 type2DM 患者：① SGLT2i，② DPP4i，③ SGLT2i/DPP4i 複方製劑，④ Insulin(每日劑量小於 60 單位)。另外本藥品不得與 DPP4i、SGLT2i 併用。

📍有關南區業務組以電腦程式檢核欣流用藥，造成正常開藥而不符年齡使用者行政核刪，已請健保署進行程式修正，並請院所對核刪有疑義時，主動聯繫承辦人員協助處理。

📍討論有關醫療資源不足地區改善方案和巡迴點未有基層診所申請辦理巡迴計畫，將提共管會和總額研商會議進一步討論。

南委會感謝各位委員、組員的參與，以及會員醫師的支持，期待共同珍惜健保資源，為維護點值而努力。貳、決議事項

提案一　　提案人：秘書處

案由：建請討論委員及審查醫藥專家出席費用。

說明：1、目前委員出席會議1,000元，出席視訊會議審由原本不給付改為一場500元，審查醫師審查費由一小時650元改為一小時700元。

2、委員視訊出席費自110年10月起計，審查醫藥專家出席費自110年第三季起計。

辦法:

項目	目前給付方式			更改後給付方式		
	親自出席	視訊出席費	交通費	親自出席	視訊出席費	交通費
委員會	$ 1,000	無	自強號來回火車票	$1,000	$ 500	自強號來回火車票
共管會	$ -	無	自強號來回火車票	$1,000	$ 500	自強號來回火車票
共識會議	$ -	無	自強號來回火車票	$1,000	$ 500	自強號來回火車票
審查專家諮詢會議	$1,000	$ 500	自強號來回火車票	$1,000	$ 500	自強號來回火車票
審查會議	$ 650	無	自強號來回火車票	$ 700	無	自強號來回火車票

決議： 照案通過。

提案二　　提案人：端木梁組長

案由：建請討論有關全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案之雲林縣土庫鎮巡迴點未有西醫基層診所申請辦理巡迴計畫。

說明：一、醫療不足地區（村里社區等），若無診所承接，或承接3-6個月後就醫人數太少，且因人數不足等原因被終止，請南區業務組儘快通知南區委員會及當地醫師公會了解原因，提供需繼續列入醫不足或排除之參考。

二、109年雲林縣莿桐鄉及土庫鎮都因新的分類方式列入，結果莿桐鄉無診所願意承接，今年土庫鎮的也是已經有診所承接，但人數太少被停止，是否有其他變通方式。

辦法:請討論。

決議：

一、請委員先於110/12/23「全民健康保險西醫基層總額研商議事會議」討論因應方式。

二、必要時函文健保署修改「110年度全民健康保險西醫醫療資源不足地區改善方案」，刪除雲林縣土庫鎮服務地點。

提案三　　提案人：端木梁組長

案由：建請討論是否把南區爭審成功的案件回饋委員會。

說明：以爭審成功的案件做為案例，提供該科討論，減少同樣狀況仍送爭審，以降低比例。

辦法:請討論。

決議:行文健保署南區業務組把案件回饋委員會,提各科科召共識會議宣導及討論。

提案四　　提案人：端木梁組長

案由：建請討論審畢抽審案件於審畢後之審查合理件數占率偏低，對於不合理案件的處理流程及有無審查不適當的可能。

說明：審畢案件由某區審查完後，若有不合理的狀況下，業務組皆會整理回饋給原審醫師及科召提供意見，目前南區審查醫藥專家無任何不當的審查狀況，但結果仍合理件數占率偏低。

辦法:請討論。

決議: 行文健保署南區業務組把案件回饋委員會,提各科科召共識會議宣導及討論。

提案五　　提案人：審查組

案由：追認重申及討論南區糖尿病下列用藥審查共識。

說明：

一、 口服降血糖藥物Metformin使用最大耐受劑量已調低為1000mg，業已於「110年3月3日第一次南區委員會會議」通過。

二、糖尿病用藥 TZD、DPP4i、SGLT2i 三者得互相轉換：符合這三類藥物的給付規定並檢附起始治療的相關病歷與檢驗報告，經具體詳實記載新的臨床症狀，有轉換的必要時，TZD、DPP4i、SGLT2i 三者得互相轉換。例如：因水腫將 TZD 轉成 DPP4i；或有 CHF、CKD、Albuminuria 將 DPP4i(或 TZD)轉成 SGLT2i 等，業已於「110 年 5 月 26 日第二次南區委員會會議」通過。

三、什麼情況可以開立TZD，DPP4 and SGLT2 inhibitors？

1、已接受Metformin使用劑量達1000mg/day，三個月以上，且HbA1仍大於等於7%之第二型糖尿病人。

2、Metformin有禁忌症（如eGFR<30）或副作用，即可第一線開立。

3、80歲以上第二型糖尿病患者，以前未使用過Metformin者(醫師裁量)；如果病患是80歲以前就已經使用metformin 且病情穩定，Creatinine正常的病

患，雖達80歲了，仍可繼續處方metformin。

四、什麼情況可以開立DPP4/SGLT2 inhibitors複方製劑？一定要連續2次HbA1c>7.5%嗎？

1、不需要，只要第6個月的HbA1c>7.5%即可。目前健保規範為限用於已接受過最大耐受劑量的metformin，且併用SGLT-2或DPP-4抑制劑治療至少6個月，糖化血色素值(HbA1c)仍高於7.5%者（僅限使用有相同成分的複方製劑）。

2、可參閱南區委員會網站提供的「三高用藥查檢表」。

辦法：請討論。

決議：照案通過。

提案六　　提案人：審查組

案由:追認HCV reflex testing申報方式及C型肝炎-核醣核酸類定量檢驗管控方法？

說明：

一、HCV reflex testing申報方式將自費用年月110年10月起生效。系提供另一種執行成人預防保健之C型肝炎抗體及RNA檢驗之申報方式，院所可自行選擇是否要執行HCV reflex testing。（見附件一）

二、若成人預防保健C型肝炎篩檢陽性，俟院所執行完成C型肝炎-核醣核酸類定量擴增試驗後，合併成人預防保健第一階段(含C型肝炎篩檢:醫令代碼L1001C)及C型肝炎-核醣核酸類定量擴增試驗(醫令代碼為12185C)申報。

三、C型肝炎抗體及RNA檢驗費用是由診所端或檢驗所端申報？是否上傳VPN雲端以資訊共享，避免重複檢驗(附件二)。

四、如何管控C型肝炎-RNA(醫令代碼為12185C)檢驗？避免重複及不需要之檢驗？

辦法：1.C 型肝炎-RNA 的檢驗要在 Anti-HCV 篩檢呈陽性後才考慮做。

2.先在 VPN 雲端查詢未做過 C 型肝炎-RNA 檢驗後才檢測，申報費用者請將檢驗結果上傳雲端共享。

3.建議健保署做 C 型肝炎-RNA 重複檢驗的 API 提醒。

4.分會將建議南區業務組對 C 型肝炎-RNA 做相關的檔案分析，並討論管控方式，以避免做重複及不必要之檢驗。

決議：照案通過

提案七　　提案人：審查組

案由：追認有關106-108年開放表別項目中，申報金額大於預估金額之項目，南區申報情況。

說明：西醫基層醫療服務審查執行會提供106-108年開放表別項目中，申報金額大於預估金額之項目表計10項，如附件三。

辦法：建議南區業務組協助分析該些項目申報之分區別、院所科別及疾病別等相關申報資料，提審查會議討論。

決議：照案通過。

提案八　　提案人：審查組

案由：追認增列糖尿病用藥GLP-1-insulin複方針劑checklist。

說明：

一、糖尿病用藥含lixisenatide及insulin glargine之複方製劑(Soliqua)已於110/7/1修正公告。

二、限用於已接受過最大耐受劑量Metformin及/或 Sulfonylurea類藥物，且併用下列藥品之一持續六個月之後，HBA1c仍高於8.0%以上之第二型糖尿病成人病人(110/7/1):

(1)SGLT-2抑制劑

(2)DPP-4抑制劑

(3)SGLT-2抑制劑合併 DPP-4抑制劑複方藥品

(4)Insulin(每日劑量小於60單位)

三、本藥品不得與DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑併用。

辦法：增列糖尿病用藥GLP-1-insulin複方針劑checklist供會員參考，如附件四。

決議： 照案通過。

提案九　　提案人：審查組

案由：追認欣流用藥審查方式。

說明：

一、最近南區業務組使用電腦程式來檢核，造成欣流4mg正常開藥且不符合年齡使用的患者被行政核刪。欣流藥物，是一種氣喘與過敏性鼻炎的慢性病用藥，有4mg、5mg、10mg三種劑量，各有建議的使用年齡。

二、建請南區業務組重新審視欣流之行政核刪程式，是否可能誤刪？

辦法：健保署目前已進行程式修正，並請院所若對核刪案件有疑義時，主動聯絡業務組承辦人員以利協助處理。

決議：照案通過。